

外用等方式,这些方式给药均会引发不良反应发生,其中尤以静脉滴注占比最高,为49.46%。静脉注射较易导致不良反应发生主要是因为抗感染药物经由血液循环传至全身,该方式药物利用度要优于其他方式,同时因为静脉滴注所致内毒素、渗透压以及微粒等变化使患者容易对抗感染药物做出反应。抗感染药物给药时应该结合实际情况进行给药,能够口服药物尽量以口服方式进行给药,可以进行注射用药就避免使用静脉滴注,一定需要静脉滴注给药者则需关注患者药物过敏史,尽量避免不良反应的发生。

头孢菌素类药物治疗为出现不良反应占比较高抗感染药物,该类药物不良反应发生较多,主要是因为此类抗感染药物抗菌谱较宽,药物化学结构稳定,安全性较高,临床应用广泛,因此所致头孢菌素类药物滥用也逐渐增多,一方面会导致抗感染药物不良反应逐渐增多,另一方面会使耐药菌产生增多,引发其抗感染作用降低,也会出现耐药菌所致不良反应。喹诺酮类抗感染药物而出现不良反应占比24.35%,临床应用喹诺酮类药物进行抗感染主要因为其抗菌作用较强,对于多种革兰阳性菌均具有强烈杀菌作用,同时不会与其他药物出现交叉耐药性,所以进行使用时不需皮肤过敏试验,可用于治疗泌尿系统、呼吸系统等多种感染,其不良反应发生率较高,可能与喹诺酮类抗菌谱广、药物治疗费用较低、临床应用较广有关。本院抗感染药物所致不良反应科室分布排名前三科室为呼吸内科、心血管内科以及肾内科,呼吸内科、心血管内科以及肾内科患者多涉及各种抗感染治疗,抗感染用药频繁,所以较易出现不良反应。本研究中73例患者痊愈或者好转,所有患者中痊愈、好转患者转归时间为0.5~38.0 d,平均转归时间 (12.53 ± 3.21) d,提示大部分由抗感染药物所致不良反应均可经过治疗或者自身身体调节消退

或者好转。

综上所述,抗感染药物所致不良反应表现在患者不同器官或者系统受损,给药方式主要为静脉滴注以及口服,不良反应发生药物多为头孢菌素类、喹诺酮类、大环内酯类,不良反应发生科室以呼吸内科、心血管内科以及肾内科为主,大部分患者不良反应可经过治疗或者自身身体调节痊愈或者减轻。在实际抗感染治疗时需要清楚了解药物不良反应,用药前进行皮试,选择适当给药方式,随时监测患者情况,减少因抗感染所致不良反应发生。

参 考 文 献

- [1] Stomski NJ, Morrison P, Meyer A. Antipsychotic medication side effect assessment tools: A systematic review. *Aust N Z J Psychiatry*, 2016, 50(5):399-409.
- [2] Tedla YG, Bautista LE. Drug Side Effect Symptoms and Adherence to Antihypertensive Medication. *Am J Hypertens*, 2016, 29(6):772-729.
- [3] Segan CJ, Baker AL, Turner A, et al. Nicotine Withdrawal, Relapse of Mental Illness, or Medication Side-Effect? Implementing a Monitoring Tool for People With Mental Illness Into Quitline Counseling. *J Dual Diagn*, 2017, 13(1):60-66.
- [4] Shaked I, Oberhardt M, Atias N, et al. Metabolic Network Prediction of Drug Side Effects. *Cell Syst*, 2016, 2(3):209-213.
- [5] 刘晓,孔妍,崔一民,等. 抗感染药物相关严重不良反应147例分析. *中国临床药理学杂志*, 2017, 33(1):70-73.
- [6] Alencar NMND, Bitencourt FDS, Luz PB, et al. Side - Effects of Irinotecan (CPT - 11), the Clinically Used Drug for Colon Cancer Therapy, Are Eliminated in Experimental Animals Treated with Latex Proteins from *Calotropis procera* (Apocynaceae). *Phytother Res*, 2017, 31(2):312-320.
- [7] 余丹阳. 严峻耐药形势下肺炎治疗中的抗菌药物联合应用原则. *中华结核和呼吸杂志*, 2018, 41(4):252-254.

[收稿日期:2020-01-07]

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用分析

廖伟中

【摘要】目的 探究喹诺酮类药物所引起的不良反应及与其他药物间的相互作用。**方法** 回顾性分析42例接受喹诺酮类药物并出现不良反应患者的临床资料,分析患者一般资料、不良反应类型、引起不良反应的药物名称及用药方式、药物联用情况。**结果** 患者所发生的不良反应中,以皮肤反应较多,占比33.33%(14/42);神经系统反应次之,占比21.43%(9/42);消化道反应占比19.05%(8/42);心脑血管反应占比11.90%(5/42);血液系统反应占比7.14%(3/42);泌尿系统反应占比4.76%(2/42),肝胆系统反应最少,占比2.38%(1/42)。引起不良反应的药物中左氧氟沙星占比最高,为54.76%;环丙沙星次之,为26.19%;莫西沙星、诺氟沙星、氧氟沙星占比较低,分别为9.52%、7.14%、2.38%。患者均为静脉注射用药。喹诺酮类药物和碱性药物、抗胆碱药、H₂受体阻滞剂、利福平、氯霉素等药物同时服用时,药效明显降低。**结论** 在临床应用喹诺酮类药物进行治疗时,要注意其应用的适应证和禁忌证,减少甚至避免不良反应的发生,提高临床用药的安全性。

【关键词】 喹诺酮类药物;不良反应;葡萄球菌;皮疹;过敏反应

DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581r.2020.14.103

作者单位:510000 广州市番禺区中医院

喹诺酮类药物是近几年被广泛使用的化学合成药之一,包括莫西沙星、左氧氟沙星等,是一种光谱抗菌药^[1]。因生物利用度较高、半衰期长、临床疗效显著而被广泛用于治疗泌尿系统、呼吸系统等疾病^[2]。但抗菌药物的长期使用均会引起人体免疫功能的降低,严重者还会引起相应的不良反应,影响患者的身心健康^[3]。因而需对此类药物不良反应的诱因、规律等进行深入研究,保障用药安全。本研究以2017年1月~2019年7月于本院接受喹诺酮类药物治疗并出现不良反应的42例患者为研究对象,回顾患者的临床治疗资料,探讨不良反应的发生原因,并分析不良反应发生情况、症状表现以及药物联用情况等,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月~2019年7月于本院接受喹诺酮类药物治疗并出现不良反应的42例患者,其中男19例,女23例;年龄19~70岁,平均年龄(47.60±11.68)岁。入组患者均符合药物不良反应的标准,且临床资料齐全,患者及家属均了解本次研究方案,并签署知情同意书,此次研究报经医院伦理委员会批准^[2]。

1.2 方法 将患者的姓名、性别、年龄、过敏史、病情、用药原因、用药名称、用药方法、用药剂量、用药时间及频率、合并用药情况、发生不良发生情况、情绪状况、生活环境状况等详细记录在本院自制的《喹诺酮类药物使用情况调查表》中,各项资料的收集采取直接询问患者、家属及主治医师,确保所用资料的完整性、准确性^[4]。

1.3 观察指标 对所有患者的临床资料进行回顾性分析,主要包括患者所处的年龄、性别、体质、过敏史等资料,分析患者不良反应类型、引起不良反应的药物名称及用药方式、药物联用情况^[5]。

2 结果

2.1 一般资料 42例患者中男19例,女23例;年龄>50岁21例,40~50岁8例,<40岁13例;过敏体质17例,非过敏体质25例;有过敏史15例,无过敏史27例。见表1。女性多于男性,年龄>50岁可能更易引发不良反应。

表1 42例患者的一般资料(n, %)

一般资料	例数	占比
性别		
男	19	45.24
女	23	54.76
年龄		
>50岁	21	50.00
40~50岁	8	19.05
<40岁	13	30.95
过敏体质		
是	17	40.48
否	25	59.52
过敏史		
是	15	35.71
否	27	64.29

2.2 不良反应类型 患者所发生的不良反应中,以皮肤反应较多,占比33.33%(14/42);神经系统反应次之,占比21.43%(9/42);消化道反应占比19.05%(8/42);心脑血管反应占比11.90%(5/42);血液系统反应占比7.14%(3/42);泌尿系统反应占比4.76%(2/42),肝胆系统反应最少,占比2.38%(1/42)。常见临床症状为皮疹、瘙痒、皮炎、恶心、呕吐、心律不齐、头晕、头痛、意识模糊、血小板下降、白细胞减少、血尿、肝功能障碍等。见表2。

2.3 引起不良反应的药物名称及用药方式 引起不良反应的药物中左氧氟沙星占比最高,为54.76%;环丙沙星次之,为26.19%;莫西沙星、诺氟沙星、氧氟沙星占比较低,分别为9.52%、7.14%、2.38%。患者均为静脉注射用药。见表3。

表2 42例患者不良反应类型(n, %)

累及系统	临床症状	例数	占比
皮肤反应	皮疹、瘙痒、皮炎	14	33.33
神经系统	头晕、头痛、意识模糊	9	21.43
心脑血管反应	心律不齐	5	11.90
消化道反应	恶心、呕吐、腹泻	8	19.05
血液系统	血小板下降,白细胞减少	3	7.14
肝胆系统	肝功能障碍	1	2.38
泌尿系统	血尿、尿频	2	4.76

表3 42例患者引起不良反应的药物名称及用药方式(n, %)

药物名称	用药方式	例数	占比
左氧氟沙星	静脉注射	23	54.76
环丙沙星	静脉注射	11	26.19
莫西沙星	静脉注射	4	9.52
诺氟沙星	静脉注射	3	7.14
氧氟沙星	静脉注射	1	2.38

2.4 药物联用情况 喹诺酮类药物和碱性药物、抗胆碱药、H₂受体阻滞剂、利福平、氯霉素等药物同时服用时,药效明显降低。

3 讨论

喹诺酮类药物是临床使用较早的抗菌药物,药物处于第一代时,抗菌谱较窄,对于常见的葡萄球菌和

· 经验交流 ·

佛山市社区心脏性猝死患者临床及流行病学特征分析

霍健杨 徐伟干

【摘要】目的 分析佛山市社区心脏性猝死患者临床及流行病学特征,以探究预防心脏性猝死的合理方案。方法 回顾性分析 372 例心脏性猝死患者的资料,分析其临床及流行病学特征。结果 372 例猝死患者中男 278 例,女 94 例。2018 年与 2019 年猝死患者的男性、女性平均年龄比较,差异均无统计学意义($P>0.05$);男性多于女性。每年猝死患者中,男性的平均年龄小于女性,差异均具有统计学意义($P<0.05$)。猝死最多的年龄段是 41~55 岁,占 36.02%。猝死的高发月份是 1 月份。发生猝死的最高时间段为 18:00~24:00。9 例(2.42%)患者受到院外人员实施心肺复苏(CPR)救助。因冠心病、急性心肌梗死猝死患者 194 例(52.15%),因心脏病、心律失常等病症猝死患者 98 例(26.34%),平时无疾病猝死患者 80 例(21.51%)。结论 佛山市社区心脏性猝死患者男性多于女性,冠心病、急性梗死是主要的猝死原因。养成健康的生活、工作习惯,大力普及心肺复苏应急、心脏性疾病预防知识,对预防心脏性猝死有重要的意义。

【关键词】社区心脏性猝死;流行病学;临床特征

DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2020.14.104

Analysis of clinical and epidemiological characteristics of sudden cardiac death in the community of Foshan city HUO Jian-yang, XU Wei-gan. Department of Emergency, Foshan First People's Hospital, Foshan 528000, China

【Abstract】Objective To analyze the clinical and epidemiological characteristics of sudden cardiac death in the community of Foshan city, so as to investigate a reasonable plan to prevent sudden cardiac death.

基金项目:佛山市卫生和计划生育局(项目编号:20170060)

作者单位:528000 佛山市第一人民医院急诊科

铜绿假单胞菌并没有抗菌作用;第二代喹诺酮类药物对铜绿假单胞菌存在抑制作用,但同时出现明显的不良反应,但发生率较低^[6];第三代时已具有抑制葡萄球菌和铜绿假单胞菌的作用,同时可以抑制革兰阳性菌,并开始在胃肠道疾病、呼吸道疾病、泌尿系统疾病的治疗中推广应用,临床疗效较为显著^[7]。近年来,喹诺酮类药物在使用过程中,消化道反应、皮肤过敏、神经系统症状等不良反应偶有发生,研究表明,这些不良反应的发生可能与患者年龄、过敏史等原因相关^[8]。本研究表明,患者所发生的不良反应中,以皮肤反应较多,占比 33.33%(14/42);神经系统反应次之,占比 21.43%(9/42);消化道反应占比 19.05%(8/42);心脑血管反应占比 11.90%(5/42);血液系统反应占比 7.14%(3/42);泌尿系统反应占比 4.76%(2/42),肝胆系统反应最少,占比 2.38%(1/42)。引起不良反应的药物中左氧氟沙星占比最高,为 54.76%;环丙沙星次之,为 26.19%;莫西沙星、诺氟沙星、氧氟沙星占比较低,分别为 9.52%、7.14%、2.38%。患者均为静脉注射用药。喹诺酮类药物和碱性药物、抗胆碱药、H₂受体阻滞剂、利福平、氯霉素等药物同时服用时,药效明显降低。

综上所述,在临床应用喹诺酮类药物进行治疗时,

要注意其应用的适应证和禁忌证,减少甚至避免不良反应的发生,提高临床用药的安全性。

参 考 文 献

- [1] 聂鲁,刘连奇,周辛波.喹诺酮类抗菌药物发展历程与临床应用.临床药物治疗杂志,2019,17(7):12-16.
- [2] 贾王平,郭代红,杨鸿溢,等.11962 例氟喹诺酮类药物不良反应报告分析及肝损害风险信号挖掘.临床药物治疗杂志,2019,17(7):34-38.
- [3] 张玄,李燕明.喹诺酮类抗菌药物在呼吸系统感染性疾病治疗中的地位.临床药物治疗杂志,2019,17(7):17-22.
- [4] 马改大.喹诺酮类抗菌药物的药理作用和临床合理应用探析.中国药物与临床,2019,19(8):1347-1348.
- [5] 杨梅,钱素云.喹诺酮类药物在儿童重症感染中的应用分析.中华急诊医学杂志,2018,27(11):1271-1275.
- [6] 尹剑辉.氟喹诺酮类药物的禁忌证不良反应及临床合理用药对策.中国药物与临床,2018,18(3):465-466.
- [7] 黄翠丽,郭代红,朱曼,等.军队医院 310 例喹诺酮类药物严重药品不良反应/事件报告分析.中国药物应用与监测,2018,15(1):28-31.
- [8] 罗兴献,刘一,薛学财,等.55 例喹诺酮类药物致血小板减少症文献分析.中国临床药理学杂志,2018,27(3):188-191.

[收稿日期:2020-02-10]